

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Medicina

Escuela Profesional de Enfermería



**“Percepción del cuidado humanizado de la enfermera en pacientes en
tratamiento antirretroviral de un centro de salud, Lima, Perú. 2024”**

Proyecto de Investigación

Para optar el Título Profesional de Licenciado en Enfermería

AUTOR

ENCARNACION PASACA, Eyder Fernando

ASESOR

DRA. CUÉLLAR FLORENCIO, María Jackeline

Lima – Perú

2024

Agradezco a mi madre por darme la oportunidad de continuar mis estudios universitarios y apoyarme incondicionalmente en cada proyecto de vida.

Agradezco a la Dra. Cuéllar Jackeline, por su orientación durante el proceso de investigación.

A cada uno de mis docentes por brindarme conocimientos, valores, principios éticos y morales.

A nuestra casa superior de estudios “Universidad Nacional Mayor de San Marcos” por haber aceptado ser parte de ella para poder realizar mis estudios superiores.

Dedico este trabajo a la sra. Pasaca, quién me vio nacer y crecer, y brindarme sus enseñanzas, valores y consejos. Por ser la persona que me apoyó en esta travesía, me motivó a seguir adelante y por haberme acompañado durante todo el trayecto de mi vida.

ÍNDICE

1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	5
1.1. Planteamiento del problema	5
1.2. Objetivos	8
1.3. Justificación de la investigación	8
1.4. Marco teórico	9
1.5. Hipótesis	19
2. CAPÍTULO II: METODOLOGÍA	19
2.1. Tipo de investigación	19
2.2. Método de investigación	19
2.3. Diseño de investigación	20
2.4. Población	20
2.5. Muestra	20
2.6. Muestreo	20
2.7. Técnicas e instrumentos. Procedimiento de recolección y análisis de datos.	21
2.8. Consideraciones éticas. Consentimiento informado.	22
3. CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN	23
3.1. Resultados	23
3.2. Discusión	25
4. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	28
4.1. Conclusiones	28
4.2. Recomendaciones	29
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	30
ANEXOS	36

Resumen

Introducción. Las personas con un diagnóstico de VIH suelen ser tratadas de manera diferente, llegando a ser estigmatizadas por su condición por el profesional de salud que le brinda atención **Objetivo.** Determinar la percepción del cuidado humanizado de la enfermera en pacientes en tratamiento antirretroviral de un centro de salud de Lima, 2024. **Metodología.** Investigación cuantitativa con abordaje descriptivo, los sujetos fueron pacientes que pertenecen al programa de TAR de un centro de salud de Lima, Perú. **Resultados.** Se evidenció que el cuidado humanizado de la enfermera es buena; sin embargo, se encontraron aspectos en los cuáles se percibía como regular. En la dimensión “Cualidades del hacer de enfermería” se encontró que un porcentaje significativo percibía el cuidado humanizado de la enfermera como regular. En la dimensión “Apertura a la comunicación”, se encontró que un porcentaje significativo percibía de forma regular el cuidado humanizado que brinda la enfermera; y por último, en la dimensión “Disposición para la atención” se encontró que hay una buena percepción; sin embargo, un porcentaje significativo percibe como regular el cuidado humanizado que brinda la enfermera. **Conclusiones.** Se determinó que la percepción del cuidado humanizado que brinda la enfermera es buena: sin embargo, existe un porcentaje significativo regular.

Palabras claves: VIH, Cuidado humanizado, enfermería, TAR, paciente, tratamiento antirretroviral.

Abstract

Introduction. People who are diagnosed with HIV are often treated differently, being stigmatized because of their condition by the health professional who is treating them.

Objectives. Determine the perception of humanized care by nurses in patients on antiretroviral treatment at a health center in Lima, 2024.

Methodology. Quantitative research with a descriptive approach, the subjects were patients who belong to the ART program at a health center in Lima, Peru.

Results. It was evident that the humanized care of nurses is good; however, there were aspects in which it was perceived as regular. In the dimension “Qualities of doing nursing” it was found that a significant percentage perceived the humanized care of the nurse as regular. In the dimension “Openness to communication”, it was found that a significant percentage perceived the humanized care provided by the nurse as regular and in the dimension “Willingness to care” it was found that there is a good perception; however, a significant percentage perceives the humanized care provided by the nurse as regular.

Conclusions. It was determined that the humanized care provided by the nurse is good; however, there is a significant percentage that perceives it as regular.

Key words: HIV, Humanized care, nursing, patient, TAR, antiretroviral treatment.

“PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE LA ENFERMERA EN PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE UN CENTRO DE SALUD, LIMA, PERÚ. 2024”

1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del problema

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere que el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) ataca al sistema inmune, en específico, a los glóbulos blancos, lo que provoca que sea más fácil el contraer enfermedades como tuberculosis, neumonía, infecciones y algunos tipos de cáncer. Se transmite por los líquidos corporales como sangre, leche materna, semen y secreciones vaginales de personas infectadas, asimismo, se puede transmitir de madre a hijo durante el período de embarazo y parto. (1)

Los síntomas de la infección pueden ser similares a los de una gripe común, como la aparición de fiebre, escalofríos, sarpullido, sudoración nocturna, dolor muscular, de garganta, entre otros, que puede aparecer y desaparecer en un lapso de tiempo entre 2 a 4 semanas, siendo nombrada infección aguda. (2)

El VIH sigue siendo uno de los mayores problemas para la salud pública a nivel mundial, habiendo cobrado alrededor de 40 millones de vidas y su transmisión sigue estando presente en todos los países y, en algunos de ellos, nuevas infecciones han ido aumentando cuando se encontraban en descenso. (1)

La ONUSIDA (2022) detectó un total de 1.3 millones de personas que se infectaron de VIH; mientras que 39 millones de personas en todo el mundo vivían con esta infección. Asimismo, 37.5 millones de personas tienen 15 años de edad a más y se tiene registro de alrededor de 630.000 personas que murieron de enfermedades relacionadas con el SIDA en todo el mundo. (3)

Por otro lado, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que el número de personas infectadas ha ido en aumento en un 4.7% desde el 2010 al 2021, con aproximadamente 100.000 nuevas infecciones en el 2021. Esta epidemia afecta de manera desproporcionada a

ciertas subpoblaciones que incluye a los hombres gais, hombres que mantienen contacto sexual con otros hombres, mujeres transgénero y las trabajadoras sexuales. En el 2021, había 3.8 millones de personas viviendo con VIH en las Américas y 2.5 millones viven en América Latina y el Caribe. Además, se estima que 1 de cada 3 personas que vive con VIH de América Latina son diagnosticadas de manera tardía, presentando inmunodeficiencia avanzada. (4)

En Perú, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y la Red Nacional de Epidemiología (RENACE) refiere que la epidemia de VIH en el país es de tipo concentrada, quiere decir que, presenta una mayor transmisión y prevalencia en poblaciones específicas. Para el 2022, se estimó que 105.795 personas vivían con la infección en el país, teniendo una prevalencia de 0.4% en adultos de 15 a 49 años de edad y una prevalencia de 10.6% en la población de hombres, y 32.8% en mujeres transgénero. En el 2023, se notificaron un total de 169.043 casos de infección, de los cuáles 50.583 fueron diagnosticados como casos de SIDA. (5)

La distribución de casos nuevos de VIH y SIDA, con relación al primero se tiene a Lima liderando la lista con un total de 41%, Loreto con 8%, Ucayali con 5%, La libertad con 5%, Callao con 5%, Piura con 4%; por otro lado, la población con SIDA lo conforman Lima con 53%, Callao con 8%, Loreto con 6%, La Libertad con 6% y San Martín con 4%, demostrando que la mayor incidencia de casos se da en departamentos de la zona oriente, costa centro y norte del país. (5)

En nuestro país, la Dirección de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis (DPVIH) del MINSA, es la unidad responsable de formular e implementar políticas, normas y lineamientos para la reducción de la transmisión del VIH, las infecciones de transmisión sexual (ITS), empleando un enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad; manejan la coordinación de estrategias para contribuir el tamizaje, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de los casos de VIH a través de los diferentes establecimientos de salud que brinden tratamiento antirretroviral (TAR) y los Centros de Referencia de Infecciones de Transmisión Sexual (CERITS). (6)

Las personas con un diagnóstico de VIH se enfrentan a diferentes situaciones o problemas como el estigma, discriminación, sufrimiento, pudiéndose sentir abrumadas por sentimientos o emociones de ansiedad y sentimiento de culpa; por lo que, esta población requiere de cuidados del profesional de enfermería, quienes deben contar con los conocimientos, habilidades y capacidades para poder brindar una atención de calidad, aplicando correctamente los cuidados relacionados a la obtención de un bienestar de salud y una mejora en el estilo de vida, mediante el cuidado humanizado. (7)

Comprendiendo que, Enfermería es ciencia y arte de cuidar, como profesionales nuestro deber es el de brindar cuidados, calidad y calidez, y que, hoy en día, el usuario solicita una atención humanizada. García y otros (México, 2022) refieren que la valoración holística al paciente es una tarea fundamental que debe realizar el profesional enfermero, debido a que, de esta forma realizan la identificación de las necesidades humanas afectadas en el paciente y, así poder realizar un adecuado Proceso de Atención de Enfermería, pues, cuando no se exhibe una buena comunicación y falta de empatía entre el binomio enfermero-paciente puede ocasionar complicaciones como falta de adherencia al tratamiento y aparición de daño psicológico al percibir un rechazo por parte del paciente de la persona que lo atiende. (8)

Como es conocido, las personas con diagnóstico de VIH suelen ser tratadas de manera diferente, incluso llegando a ser estigmatizadas por su condición por el profesional de salud que le está atendiendo, lo que termina ocasionando un rechazo y resentimiento, que podría perjudicar su adherencia al tratamiento y/o hasta abandonarlo.

1.1.1. Formulación del problema

- ¿Cuál es la percepción sobre el cuidado humanizado de la enfermera en pacientes en tratamiento antirretroviral de un centro de salud de Lima, 2024?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Determinar la percepción del cuidado humanizado de la enfermera en pacientes en tratamiento antirretroviral de un centro de salud de Lima, 2024.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Identificar la percepción del cuidado humanizado de la enfermera en pacientes en tratamiento antirretroviral en la dimensión cualidades del hacer de enfermería.
- Identificar la percepción del cuidado humanizado de la enfermera en pacientes en tratamiento antirretroviral en la dimensión apertura para la comunicación.
- Identificar la percepción del cuidado humanizado de la enfermera en pacientes en tratamiento antirretroviral en la dimensión disposición para la atención.

1.3. Justificación de la investigación

1.3.1. Práctico

Este proyecto de investigación permitirá ser base para otras investigaciones que deseen abordar el tema del cuidado humanizado en poblaciones con VIH o en tratamiento antirretroviral, tanto para mejorar como contribuir en el desarrollo y gestión de lo que debe realizar el profesional de enfermería en su labor diario en el área comunitaria.

1.3.2. Teórico

Esta investigación, al realizar un estudio sobre las dimensiones del cuidado para con el paciente, nos permitirá la elaboración de guías de enfermería para que se pueda garantizar la realización de un cuidado individualizado oportuno, eficiente y humanizado que, tendría influencia en el bienestar físico, psicológico, social y espiritual del paciente.

En este estudio se podrá conocer sobre la percepción del paciente en cuánto al trato humanizado y será beneficioso para el personal de la salud tratante, en especial para el profesional de enfermería, puesto que, así se podrá reconocer y reflexionar acerca de la calidad de atención que se brinda y el trato humanizado que se le debe brindar a los pacientes que asisten al servicio.

Por consiguiente, los datos obtenidos en la investigación serán entregados al servicio de TAR para su conocimiento, además, los resultados serán dispuestos para que continúen investigaciones relacionadas al cuidado humanizado y, de esta forma, mejorar el trato y brindar una atención humanizada al paciente con diagnóstico de VIH con la finalidad de asegurar su bienestar y adherencia al tratamiento.

1.4. Marco teórico

1.4.1. Antecedentes

Tejada, Viviana (2019) en su investigación titulada “Percepción del paciente con VIH sobre el cuidado humanizado que brinda el profesional de enfermería en el servicio de centro quirúrgico en un hospital nacional de Lima, 2019”, tiene como objetivo determinar la percepción sobre el cuidado humanizado en pacientes con VIH que brinda el personal de enfermería en el servicio de centro quirúrgico en un hospital nacional de Lima, es una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo, con un diseño no experimental y corte transversal, contando con una población censal conformada por 60 pacientes con VIH que acuden al centro quirúrgico en el período enero - junio del 2019. (9)

Rojas, Onan (2019), en su investigación titulada “Percepción del usuario acerca del cuidado humanizado de enfermería a personas con VIH/Sida atendidos en el hospital general de Jaén, 2018”, cuyo objetivo fue determinar la percepción del usuario acerca del cuidado humanizado de enfermería a personas con VIH/Sida atendidos en el Hospital General de Jaén, es una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo y diseño transversal, con una población conformada por 90 usuarios atendidos en la Estrategia Sanitaria de Control y Prevención de VIH/Sida, su muestra fue de 59 usuarios escogidos por muestreo no probabilístico, en sus

resultados refieren que el profesional de enfermería le permite expresar sus sentimientos sobre la enfermedad y el tratamiento, le brinda un cuidado adecuado y oportuno; y a veces identifica sus necesidades de tipo físico, psicológico y espiritual, le ayuda a tomar medidas preventivas para evitar enfermedades y le explica oportunamente ante alguna inquietud. (10)

Chuquín, Emily y Correa, Lizbeth (2023), en su investigación titulada “Calidad de vida y adherencia al TARGA en personas con VIH en el Hospital de Ventanilla, Lima - Perú 2023”, cuyo objetivo fue determinar la relación entre la calidad de vida y la adherencia al TARGA en personas con VIH en el Hospital de Ventanilla, Lima - Perú 2023, es una investigación cuantitativa, de enfoque correlacional y no experimental, con una población de 80 pacientes, siendo todos parte de la muestra, muestreo de tipo no probabilístico por conveniencia, en sus resultados evidencia que el 56% de su muestra tuvo entre 30 a 48 años; el 55% era de sexo masculino y que el 30% son solteros. Asimismo, con relación a la calidad de vida en la dimensión salud física, se observó que el 73.75% de las personas con VIH presentaba una calidad de vida deficiente. (11)

Herrera, Vilma *et al.* (2020) en su investigación “Percepción del Cuidado Humanizado de Enfermería en Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica” cuyo objetivo fue describir la percepción del cuidado humanizado de enfermería en un grupo de pacientes con IRC que asistían a la Unidad de Diálisis del Hospital General de Machala, Ecuador; refiere según lo planteado por Jean Watson, el cuidado es esencia de la práctica de enfermería y que, la empatía, la comprensión e intencionalidad son factores fundamentales para que los profesionales de enfermería y sus pacientes puedan formar una conexión humana que llegue a trascender la medicalización y control terapéutico, es un estudio descriptivo, de diseño transversal, con una población censal de 72 pacientes, sus resultados refieren que las dimensiones evaluadas se encontraban con puntuaciones promedio altas, concluyendo que los pacientes que asisten a la Unidad de Diálisis del Hospital General de Machala perciben un alto nivel de cuidado humanizado por parte de los profesionales de enfermería, además, las dimensiones relacionadas con la expresión emocional y los aspectos espirituales del cuidado representan una oportunidad para la mejora en la atención de enfermería según el marco de la teoría del Cuidado Humanizado. (12)

1.4.2. Referente Teórico

1.4.2.1. VIH/SIDA

El VIH es un retrovirus con envoltura que contiene dos copias de un genoma de ARN monocatenario perteneciente a la familia de *Retroviridae* en el género *Lentivirus*, siendo aislado e identificado por primera vez en 1983, que, sin tratamiento, todos los pacientes que presenten una infección por VIH desarrollan inmunosupresión grave, que es la causa de múltiples infecciones oportunistas y neoplasias malignas relacionadas. La última etapa de la infección ocasionada por el VIH se denomina SIDA.

Además, algunos pacientes pueden presentar quejas de síntomas inespecíficos al momento de la infección primaria o aguda, sin embargo, optan por ignorarlos y no buscar atención médica, por lo que, no terminan recibiendo un tratamiento; luego inicia la fase crónica asintomática de la infección, que puede terminar durante décadas; al final, solo queda la fase final de la enfermedad que se define por la aparición de infecciones oportunistas invasivas graves o neoplasias malignas relacionadas con el VIH, siendo denominadas lesiones definitorias del Sida.

El VIH se transmite a través de una variedad de fluidos corporales, como la leche materna, sangre, secreciones vaginales y semen, asimismo, puede transmitirse durante el embarazo y el parto. Por otro lado, se ha identificado a las poblaciones clave que llegan a ser afectados de manera desproporcionada, entre ellos se encuentran los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), los trabajadores sexuales (TS), las personas en prisión y otros entornos cerrados, las personas que se drogan por medio de inyección y la población trans y de género diverso. (13)

1.4.2.2. Tratamiento

El tratamiento es con terapia antirretroviral (TAR), este consiste a menudo en tres o más medicamentos de administración diaria para ayudar a reducir la carga viral del VIH en sangre a un nivel indetectable, permitiendo la recuperación del paciente infectado, pueden ocurrir complicaciones relacionadas con la enfermedad, incluso en pacientes no

tratados con recuentos alto de CD4, además, la toxicidad ocasionada por esta terapia ha disminuido a medida del desarrollo de nuevos fármacos. (14) (15) (16)

La combinación del medicamento varía con cada caso en función de:

- La etapa de la enfermedad
- Si la infección es o no es resistente a cualquiera de los medicamentos del TAR
- Efectos secundarios
- Afecciones médicas que presente la persona.

El TAR puede alcanzar su objetivo si los pacientes cumplen con un nivel mayor al 95% del tratamiento farmacológico, si el tratamiento fracasa, los ensayos definen la susceptibilidad o resistencia farmacológica, pudiendo así determinar la susceptibilidad de la cepa de VIH predominante a todos los fármacos disponibles. Puesto que muchos pacientes que viven con la infección están tomando regímenes complejos que involucran múltiples píldoras. (17) (18)

Asimismo, los antirretrovirales pueden provocar efectos adversos significativos como la anemia, hepatitis, insuficiencia renal, pancreatitis, intolerancia a la lactosa, por lo que, se le recomienda al paciente realizarse chequeos de manera periódica, tanto por la clínica como con pruebas de laboratorio apropiadas, hemograma, pruebas de sangre, hiperglucemia, hiperlipidemia, función renal y hepática, análisis de orina, entre otros; luego de haber sido recetado con fármacos nuevos o del desarrollo de síntomas de etiología dudosa. (19)

Según la Guía Técnica “Salud de Atención Integral del Adulto con infección por el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)” el inicio del TAR se debe realizar dentro del plazo más corto posible, de no haber completado la evaluación del equipo multidisciplinario, estas se podrán completar luego de haber iniciado el tratamiento. La evaluación médica debe incluir una anamnesis adecuada y un examen físico completo, haciendo especial énfasis en la búsqueda de signos de inmunosupresión y la presencia de enfermedades oportunistas.

La indicación del inicio en toda persona con infección por VIH es independiente del estadio clínico y/o recuento de linfocitos T-CD4 y carga viral presente, así como contar con los exámenes auxiliares correspondientes como pruebas básicas de laboratorio que incluye; hemograma completo, transaminasa glutámico pirúvica (TGP), glucosa en ayunas, creatinina sérica; radiografía de tórax, baciloscopias en esputo para descarte de TB pulmonar, detección de otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y recuento basal de linfocitos T-CD4.

El ingreso al TAR es voluntario y se realiza previa información al paciente sobre los beneficios y riesgos que presenta el tratamiento, de los riesgos de no recibir oportunamente el tratamiento antirretroviral, así como de sus derechos y obligaciones que tiene como paciente. El consentimiento del paciente de iniciar el tratamiento se documenta a través de la *“Hoja de Consentimiento Informado para el inicio del Tratamiento Antirretroviral en el Adulto con VIH”*, el cuál debe ser firmado por el paciente y por el médico tratante.

Los esquemas de tratamiento para los pacientes nuevos están basados en la combinación de dos medicamentos inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa (INTR), más un tercer medicamento, el cuál se elige de acuerdo a la evaluación individual de los pacientes; por otro lado, el esquema de primera línea de elección para pacientes adultos con infección sin antecedentes de uso será:

- Tenofovir 300 mg/Lamivudina 300 mg/Dolutegravir 50 mg de una tableta de Dosis Fija Combinada (DFC) cada 24 horas.

Si el uso del esquema de elección está contraindicado o si se presentan eventos adversos relacionados al uso de Dolutegravir, el esquema seleccionado será:

- Tenofovir 300 mg/Lamivudina 300 mg/Efavirenz 400 mg; 1 tableta en DFC cada 24 horas.
- Tenofovir 300 mg/Emtricitabina 200 mg/ Efavirenz 600 mg; 1 tableta en DFC cada 24 horas.

Si el uso de Tenofovir (TDF), está contraindicado, será reemplazado por Abacavir (ABC), prefiriéndose esquemas en DFC, asimismo, al emplear este nuevo medicamento se debe recomendar contar previamente con un resultado de la prueba Antígenos Leucocitario Humano (HLA) negativo, el cuál se puede pedir al Instituto Nacional de Salud (INS), y se debe informar al paciente sobre la posible aparición de una reacción de hipersensibilidad a ABC, que suele aparecer a los 9 días de la exposición y se caracteriza por la presencia de fiebre, náuseas, vómitos, mialgias, diarreas, dolor abdominal y, de no ser reconocido a tiempo, puede evolucionar al shock, distrés respiratorio y, eventualmente, la muerte. (20) (21)

En los casos que el paciente haya sido tratado anteriormente o abandono el TAR, se deberá reiniciar el último esquema que estuvo recibiendo y realizar un control virológico a las 6 a 8 semanas de tratamiento. En el caso de mujeres con VIH, se tiene en cuenta las interacciones con los anticonceptivos antes de iniciar o cambiar un esquema de tratamiento. La gestante con VIH, por otro lado, debe ser atendida de manera integral de acuerdo a lo dispuesto en las normas vigentes.

1.4.2.3. Adherencia al TAR

Para favorecer y asegurar la adherencia al TAR se debe adecuar la toma de medicamentos a la rutina que el paciente ha escogido, considerando tolerancia al número, tamaño y frecuencia de toma de pastillas, así como el horario establecido para su toma.

Se debe brindar educación y consejería en el tratamiento como líneas de acción para la adherencia, técnica que deben incluir refuerzos positivos. Además, el equipo multidisciplinario debe identificar a los pacientes con factores de riesgo para una mala adherencia como violencia, de tipo familiar y/o sexual, uso y consumo de alcohol y drogas y otras sustancias, problemas de salud mental y psicológica, como depresión, conductas autodestructivas, ansiedad, entre otros; con la finalidad de hacer un trabajo preventivo a través de la consejería de soporte e intervención psicológica. (22)

Asimismo, los pacientes con diagnóstico de VIH suele ser estigmatizado por el profesional de la salud durante su atención en los servicios de TAR, tanto para su control de leucocitos, como en la entrega de su profilaxis, llegando a perjudicar en su percepción sobre el trato humanizado que debe tener y provocando una pérdida de adherencia al tratamiento, perjudicando su salud.

1.4.2.4. Paciente

Según la Clínica Universidad de Navarra (CUN) (2023) paciente es todo individuo que busca atención o recibe cuidados de salud debido a alguna enfermedad, lesión, para mejorar el bienestar, prevenir enfermedades y/o para obtener diagnósticos sobre su condición de salud actual. (23)

Según Elio, Daniel (2022) se refiere, por medio del modelo biomédico, como una máquina corporal compuesta de partes separadas que interactúan con un objetivo final que es el funcionamiento, por otro lado, mediante el modelo humanista, se menciona al paciente como un sujeto encarnado en términos de cuerpo y mente integrados en una persona única. (24)

1.4.2.5. Cuidado

Según Leonardo Boff (2020) refiere que el cuidado pertenece a la esencia de todo ser humano, así como de todo lo que existe y vive; y todo lo que hacemos va acompañado de cuidado, pudiendo ser entendido por todos porque todos lo experimentan a cada momento; asimismo, expresa tres sentidos básico, el primero, lo expresa como una relación amorosa, amable, amistosa y protectora con los enfermos; el segundo, el cuidado es cualquier tipo de implicación que tengamos con los enfermos a los que, en cierto nivel, dediquemos empatía y tiempo de curación; y el tercero, es la conexión que presentan los seres humanos con el planeta, pues existe una comunidad de destino común entre nosotros y la Tierra. (25)

El cuidado es el objeto de estudio que poseen los profesionales de enfermería, asimismo, es una necesidad que permite la conservación, mantenimiento y desarrollo de la salud de

la persona, familia y comunidad. Además, el cuidado brindado por el profesional de enfermería se distingue del cuidado innato porque el primero busca tratar de establecer un proceso intencional de querer ayudar a los otros en su proceso de salud, enfermedad y muerte. (26)

Según Hidalgo, Brenda y Altamira, Ramiro (2021) refiere que comprender el cuidado, implica comprender dos aspectos filosóficos, uno partiendo desde la filosofía de la ciencia de enfermería, se puede asumir este por medio de los parámetros ofrecidos por medio de las teoristas de esta profesión que se encuentran orientadas a humanizar la práctica profesional; dos, se tiene una fuerte contribución del existencialismo, por medio del humanismo, permitiendo una interacción del cuidado como modo de ser; dándonos una comprensión del cuidado humanizado desde la perspectiva disciplinar con Watson. (27)

1.4.2.6. Cuidado Humanizado

Según Aquino, Ronal (2020) Watson indica que la acción de cuidar es parte esencial del ser, así como también es un acto innato que realiza el ser humano a otro ser humano que requiera de ayuda, esta invocación al otro ser es el escalón fundamental para la profesión de enfermería, puesto que, el cuidado que brindan es establecido, orientado y organizado para cubrir las necesidades con el fin de conservar y fomentar la salud. Por otro lado, se complementa con la obligación moral y una abierta voluntad de cuidar a través de la comunicación transpersonal. (28)

Según Cruz, Consuelo (2020) nos refiere que la realización del cuidado humanizado para ser desempeñado requiere de la comprensión de la existencia de los atributos básicos: el ser humano, es considerado un sistema complejo que presenta características genéticas, conjugadas con la exposición con el medio ambiente, permitiendo la adaptación y evolución, por otro lado, se le considera como la tríada cuerpo, mente y alma, que está influido por energía y naturaleza; relación profesional - usuario, busca la reflexión sobre la relación profesional - usuario, como atributos básicos en la naturaleza del cuidado humanizado, además, se indica que trabajar permite tender hacia el propio

perfeccionamiento, obtener la satisfacción de las necesidades vitales; acto del cuidado, menciona que se centra en el acto de cuidar como parte de la esencia que posee el ser humano, por lo que, la manera de desarrollo del acto mostraría una relación directa entre la calidad de vida y la vida, asimismo, Watson menciona que este acto requiere de un llamado al esfuerzo moral, ético, ontológico, epistemológico, filosófico y práctico; comunicación, este es un atributo del ser humano y que solo mediante este podemos alcanzar una cercanía real, volviéndose así un atributo indispensable; y enfoque holístico, hace mención a generar condiciones favorables para la recuperación y sanación, siendo producto de un equilibrio energético alcanzado. (29)

Watson citada por Izquierdo, Esther (2015) sustenta su trabajo en desarrollar una base moral y filosófica significativa en la labor del personal de enfermería, pues debido al avance tecnológico y científico el trato al paciente se viene deshumanizando; asimismo, la “Teoría del cuidado humano” considera el aspecto humano en el proceso del cuidado enfermero. (30)

1.4.2.7. Percepción

La percepción es un proceso simple, donde en el estímulo está la información, sin necesidad de pensamientos mentales internos posteriores. Asimismo, es un proceso activo - constructivo en el que el perceptor construye un esquema informático anticipatorio que le permite contrastar el estímulo y así poder aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto. (31)

Los procesos de la percepción son dos: el primero trata de la acumulación de los datos que nos llegan del ambiente externo, reduciendo su complejidad y facilita su almacenamiento y recuperación en la memoria; como segundo proceso se tiene a la información adquirida, lo que lleva a una predisposición, con la finalidad de poder predecir acontecimientos futuros a los hechos y evitar o reducir la sorpresa ante los acontecimientos. (32)

1.4.2.8. Medición de la percepción

El instrumento Percepción de Comportamientos de Cuidado Humanizado de Enfermería (PCHE) fue diseñado en el año 2003 y, actualmente, se encuentra en su tercera versión (PCHE-III) el cuál mide y operacionaliza el concepto del cuidado humanizado en tres dimensiones para su análisis, el primero priorizar al sujeto de cuidado; apertura a la comunicación para proporcionar educación para la salud a la persona; y cualidades del hacer de la enfermería. Además, este instrumento ha sido empleado en diversas investigaciones en América Latina para medir el cuidado humanizado ofrecido en diferentes servicios e instituciones hospitalarias.

El instrumento PCH-I fue sometido a una validación facial mediante la técnica de juicio de expertos, obteniendo un instrumento con 50 reactivos, en donde cada ítem involucra un comportamiento de cuidado, usando como base a la Teoría del Cuidado Humano y en la Teoría de la Enfermería como Cuidado. (33)

El PCHE-III tiene un alfa de Cronbach de 0.92 y consta de 32 ítems con formato de escala de Likert, las preguntas tributan a tres dimensiones calidad, comunicación y disposición. (34) (35)

1.4.2.9. Profesional de Enfermería

Es el profesional encargado de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y quién presta los cuidados a las personas que padecen de enfermedades físicas, mentales, a las personas que presentan algún tipo de discapacidad, de todas las edades, en todos los entornos de atención de salud y otros ámbitos relacionados a la comunidad. (36) (37)

La OPS (2024) refiere que el profesional de enfermería son clave para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, así como son la columna vertebral de los sistemas de atención sanitaria que hay en el mundo, puesto que, laboran en la primera línea de atención abordando la prevención de enfermedades, la gestión y promoción de la salud. (38)

Según De Arco, Oneys y Suarez, Zuleima (2018) la enfermería es una disciplina profesional que se enfoca en los cuidados autónomos para con el paciente, familia y comunidad, estén enfermos o sanos y estos cuidados incluyen a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y cuidados personalizados en personas con discapacidad y moribundas. Asimismo, el profesional de enfermería debe estar capacitado para brindar cuidados a toda la población, independientemente de su condición, esta atención brindada debe priorizar y garantizar el bienestar y priorizando la salud del paciente. (39)

Para Watson, define a la enfermería como un conjunto de conocimiento, pensamiento, valores, filosofía, compromiso y acción sumado a cierto grado de pasión y, que en nuestra práctica diaria, debemos basarnos en valores humanísticos donde comprendemos los sentimientos del otro y a la vez poder expresarlos de manera semejante.

1.5. Hipótesis

- No cuenta con una hipótesis al ser una investigación descriptiva.

2. CAPÍTULO II: METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación

El tipo de investigación de este proyecto es descriptivo porque la información será recolectada sin realizar algún cambio en el entorno. (40)

2.2. Método de investigación

Según Ñaupas (2015) el presente proyecto de investigación presenta un método cuantitativo, debido a que, va a permitir recoger y analizar datos cuantitativos mediante el empleo de recolección de datos y el análisis de datos. (41)

2.3. Diseño de investigación

El diseño que se emplea en este proyecto es de tipo no experimental, se caracteriza por la no intervención ni manipulación de las variables a estudiar. (42)

2.4. Población

La población se encuentra conformada por los pacientes adultos entre 18 a 59 años de edad, de ambos sexos, masculino y femenino, con diagnóstico médico de VIH que se atienden en el Servicio de Atención Integral de ITS (SAITS) del Centro de Salud “Max Arias Schreiber”, pertenecientes al programa de TAR. Se cuenta con una población de 100 pacientes que asisten de manera mensual al servicio.

2.5. Muestra

El tamaño de la muestra está conformada por 80 pacientes.

Se terminó aplicando el instrumento a un total de 95 pacientes pertenecientes al servicio de SAITS.

2.6. Muestreo

El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia, pues el investigador escogerá a las personas que conformarán la muestra por medio de los criterios.
(43)

Criterios de inclusión

- Personas con diagnóstico de VIH.
- Personas mayores de 18 años y menores de 59 años.
- Personas en tratamiento antirretroviral.
- Personas de sexo masculino.
- Personas de sexo femenino.

Criterios de exclusión

- Personas con adherencia al tratamiento menor a 6 meses.
- Personas que se encuentren en estadio SIDA.
- Personas que no firmen el consentimiento informado.
- Personas que no completen el cuestionario.

2.7. Técnicas e instrumentos. Procedimiento de recolección y análisis de datos.

Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario (Anexo 3), organizado en 2 partes; la primera abarca los datos sociodemográficos de los pacientes y la segunda parte corresponde a la percepción del cuidado humanizado de la enfermera en pacientes en tratamiento antirretroviral.

La variable está organizada en 30 ítems, con un patrón de respuesta de 4 criterios, que presentan un puntaje respectivamente:

- Siempre: 4
- Casi siempre: 3
- Algunas veces: 2
- Nunca: 1

2.7.1. Validez y confiabilidad del instrumento

Para medir la variable de objeto de estudio se utilizó el instrumento “Percepción de comportamientos de cuidado humanizado de enfermería PCHE 3° versión” de Gonzales (35), realizado en Bogotá, Colombia; y tiene un índice de aceptabilidad de 0.92 y un índice de validez de contenido de 0.98 por expertos, y tiene un alfa de Cronbach de 0.96.

Los ítems del instrumento se adaptaron a la realidad local, modificando el sentido de los mismos realizado por el autor de la investigación.

Para la validez del instrumento de estudio se sometió a juicio de expertos, conformados por 5 licenciados de enfermería, con la finalidad de evaluar la claridad, precisión, congruencia de ítems, amplitud de contenido y redacción de ítems. Presentó una claridad de 0.90 y una relevancia de 0.95. (Anexo 1)

2.7.2. Análisis de datos

El procesamiento de la información se realizó de forma electrónica utilizando el programa Microsoft Excel 2010. Los datos fueron presentados en tablas y gráficos, y para el análisis se utilizó estadística descriptiva.

2.8. Consideraciones éticas. Consentimiento informado.

Principio de autonomía

Se respetará la decisión del participante en caso acepte o rechace el llenado del cuestionario, así como no influir ni manipular sus respuestas.

Principio de beneficencia

Se priorizará el anonimato del participante y se aceptará cuando este decida no responder alguna pregunta o retirarse en medio del llenado del cuestionario.

Principio de no maleficencia

Ninguno de los participantes será obligado a realizar el llenado del cuestionario.

Principio de justicia

Se aceptará el llenado del cuestionario a todo participante interesado.

3. CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Resultados

GRÁFICO N°1. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE LA ENFERMERA EN PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE UN C.S. DE LIMA, PERÚ. 2024

Percepción del Cuidado Humanizado en pacientes en tratamiento antirretroviral en un centro de salud de Lima, Perú. 2024

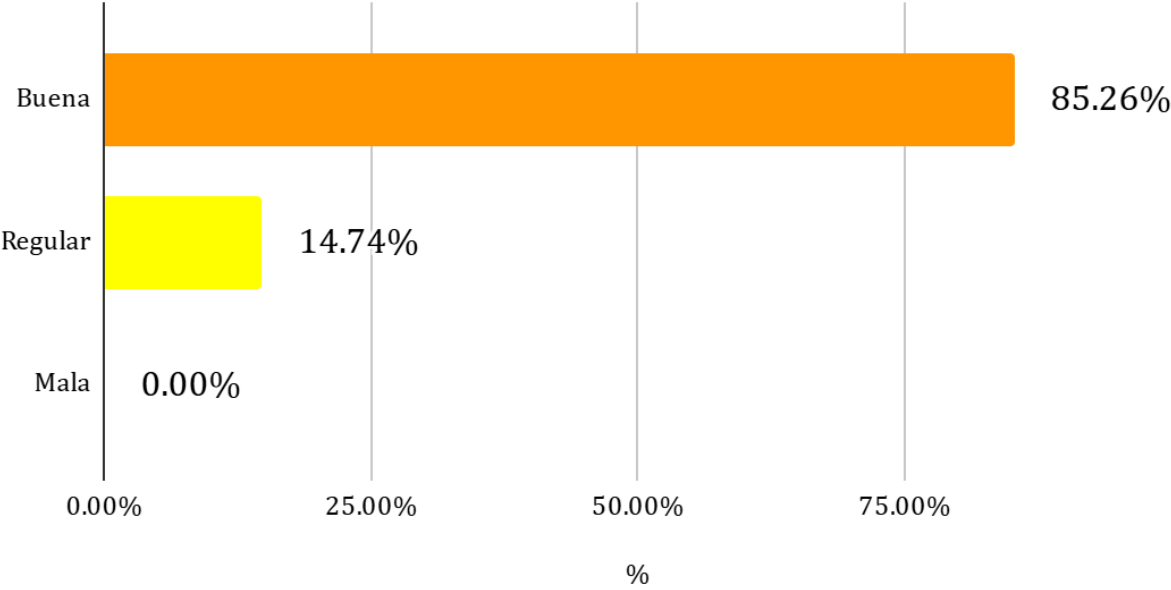
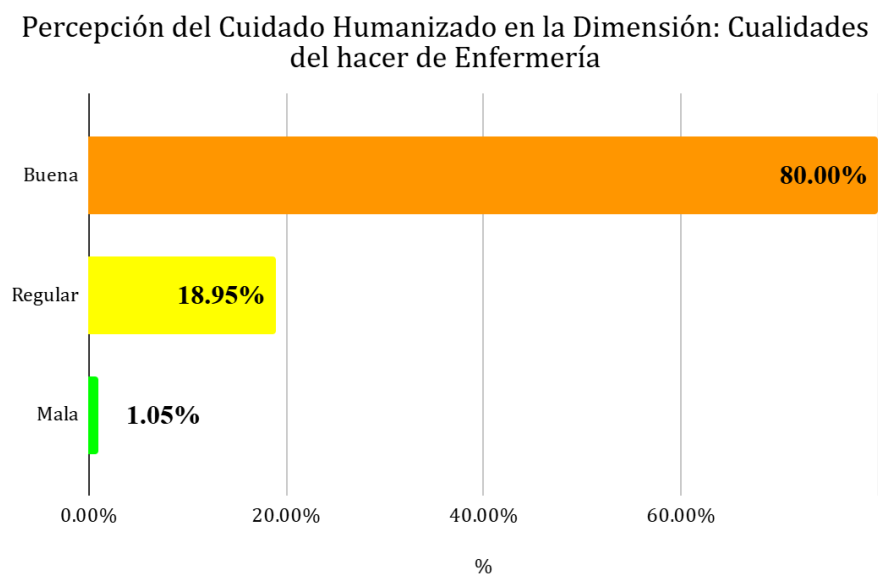


TABLA 1. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE LA ENFERMERA EN PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE UN C.S. DE LIMA, PERÚ. 2024

Percepción del Cuidado Humanizado				
	Mínimo	Máximo	n	%
Buena	90	120	81	85.26%
Regular	60	89	14	14.74%
Mala	30	59	0	0.00%

El 85.26% (81) presenta una buena percepción del cuidado humanizado de la enfermera en pacientes en tratamiento antirretroviral de un C.S. de Lima, Perú. 2024. El 14.74% (14) presenta una regular percepción del cuidado humanizado de la enfermera. La gráfica se realizó a partir de la tabla 1 (Anexo 8)

GRÁFICO N°2. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE LA ENFERMERA EN PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE UN C.S. DE LIMA. PERÚ. 2024. DIMENSIÓN: CUALIDADES DEL HACER DE ENFERMERÍA.



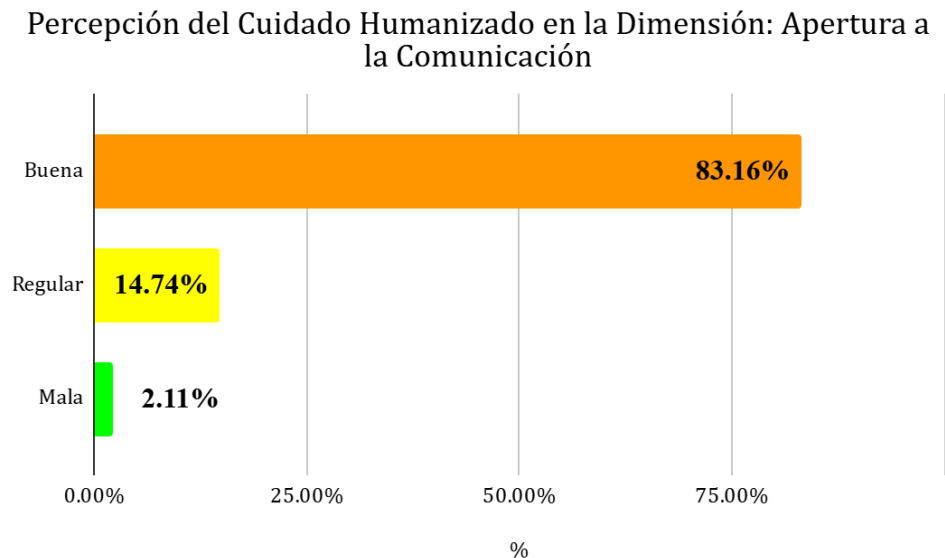
El 80% (76) presenta una buena percepción del cuidado humanizado de la enfermera en pacientes en tratamiento antirretroviral de un C.S. de Lima, Perú. 2024. en la dimensión cualidades del hacer de enfermería; el 18.95% (18) presenta una regular percepción del cuidado humanizado de la enfermera; y por último, el 1.05% (1) presenta una mala percepción del cuidado humanizado de la enfermera.

TABLA 2. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE LA ENFERMERA EN PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE UN C.S. DE LIMA. PERÚ. 2024. DIMENSIÓN “CUALIDADES DEL HACER DE ENFERMERÍA”

Percepción del Cuidado Humanizado en la Dimensión: Cualidades del hacer de Enfermería				
	Mínimo	Máximo	n	%
Buena	22	28	76	80.00%
Regular	15	21	18	18.95%
Mala	7	14	1	1.05%

D1: CUALIDADES DEL HACER DE ENFERMERÍA								
ITEM	1: Nunca		2: Algunas veces		3: Casi Siempre		4: Siempre	
	n	%	n	%	n	%	n	%
P1: La enfermera lo hace sentir como persona.	1	1.05%	7	7.37%	14	14.74%	73	76.84%
P2: La enfermera lo trata con amabilidad cuando lo atiende.	1	1.05%	5	5.26%	22	23.16%	67	70.53%
P6: Le hacen sentirse bien atendido cuando dialogan con usted.	1	1.05%	8	8.42%	19	20.00%	67	70.53%
P7: Le hacen sentir tranquilidad cuando están con usted.	2	1.05%	8	8.42%	25	26.32%	60	63.16%
P8: Ud. siente un ambiente de confianza cuando lo atienden.	2	1.05%	7	7.37%	25	26.32%	61	64.21%
P15: Le explican los cuidados usando un tono de voz pausado.	1	1.05%	6	6.32%	28	29.47%	60	63.16%
P17: Le demuestran respeto por sus creencias y valores.	1	1.05%	3	3.16%	24	25.26%	67	70.53%

GRÁFICO N°3. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE LA ENFERMERA EN PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE UN C.S. DE LIMA, PERÚ. 2024. EN LA DIMENSIÓN: APERTURA PARA LA COMUNICACIÓN.



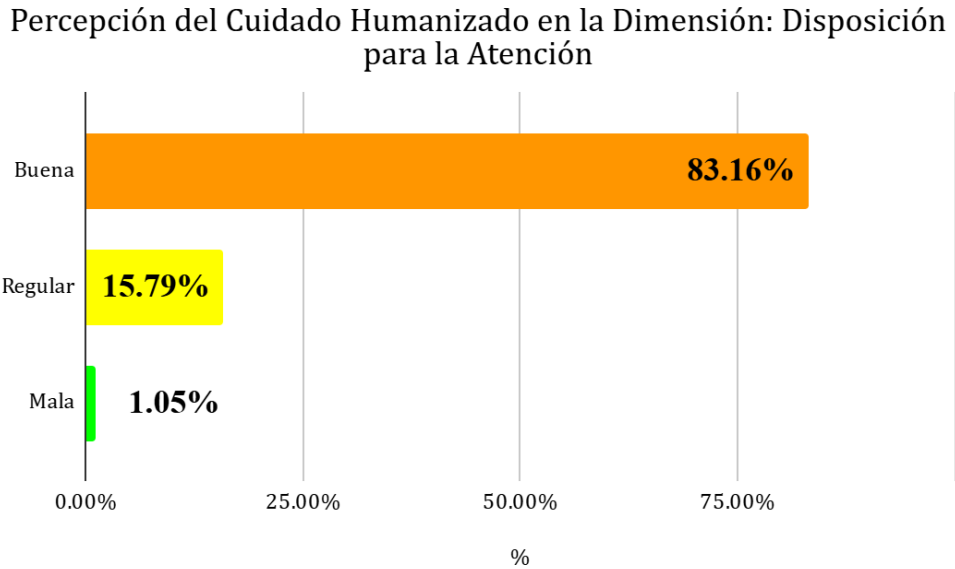
El 83.16% (79) presenta una buena percepción del cuidado humanizado de la enfermera en pacientes en tratamiento antirretroviral de un C.S. de Lima, Perú. 2024, en la dimensión apertura a la comunicación; el 14.74% (14) presenta una regular percepción del cuidado humanizado de la enfermera y, por último, el 2.11% (2) presenta una mala percepción del cuidado humanizado.

TABLA 3. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE LA ENFERMERA EN PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE UN C.S. DE LIMA. PERÚ. 2024. DIMENSIÓN “APERTURA A LA COMUNICACIÓN”

Percepción del Cuidado Humanizado en la Dimensión: Apertura a la Comunicación				
	Mínimo	Máximo	n	%
Buena	24	32	79	83.16%
Regular	16	23	14	14.74%
Mala	8	15	2	2.11%

D2: APERTURA A LA COMUNICACIÓN								
ITEM	1: Nunca		2: Algunas veces		3: Casi Siempre		4: Siempre	
	n	%	n	%	n	%	n	%
P4: La enfermera lo mira a los ojos cuando se comunica con Ud.	2	2.11%	13	13.68%	29	30.53%	51	53.68%
P5: La enfermera dedica tiempo para aclararle sus inquietudes.	2	2.11%	6	6.32%	31	32.63%	56	58.95%
P9: La enfermera facilita el diálogo con Ud.	2	2.11%	14	14.74%	23	24.21%	56	58.95%
P10: Le explican previamente los procedimientos.	2	2.11%	8	8.42%	25	26.32%	60	63.16%
P11: Le responden con seguridad y claridad sus preguntas	1	1.05%	5	5.26%	26	27.37%	63	66.32%
P12: Lo llaman por su nombre antes de realizar un procedimiento.	4	4.21%	6	6.32%	17	17.89%	68	71.58%
P14: La enfermera brinda indicaciones sobre su atención cuando usted lo requiere o según su situación de salud.	1	1.05%	5	5.26%	32	33.68%	57	60.00%
P19: Le proporcionan información suficiente y oportuna para que pueda tomar decisiones sobre su situación de salud.	2	2.11%	6	6.32%	25	26.32%	62	65.26%

GRÁFICO N°4. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE LA ENFERMERA EN PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE UN C.S. DE LIMA, PERÚ. 2024. EN LA DIMENSIÓN: DISPOSICIÓN PARA LA ATENCIÓN.



El 83.16% (23) presenta buena percepción del cuidado humanizado de la enfermera en pacientes en tratamiento antirretroviral de un C.S. de Lima, Perú. 2024 en la dimensión disposición para la atención; el 15.79% (7) presenta regular percepción del cuidado humanizado de la enfermera y, por último, el 1.05% (1) presenta una mala percepción.

TABLA 4. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE LA ENFERMERA EN PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE UN C.S. DE LIMA, PERÚ. 2024. EN LA DIMENSIÓN DISPOSICIÓN PARA LA ATENCIÓN.

Percepción del Cuidado Humanizado en la Dimensión: Disposición para la Atención				
	Mínimo	Máximo	n	%
Buena	45	60	79	83.16%
Regular	30	44	15	15.79%
Mala	15	29	1	1.05%

D3: DISPOSICIÓN PARA LA ATENCIÓN								
ITEM	1: Nunca		2: Algunas veces		3: Casi Siempre		4: Siempre	
	n	%	n	%	n	%	n	%
P3: La enfermera muestra interés para brindarle comodidad al entregarle su medicamento.	1	1.05%	5	5.26%	22	23.16%	67	70.53%
P13: La enfermera dedica el tiempo requerido para su atención.	2	2.11%	3	3.16%	33	34.74%	57	60.00%
P16: La enfermera lo llama por su nombre.	5	5.26%	7	7.37%	19	20.00%	64	67.37%
P18: Lo atienden oportunamente.	1	1.05%	6	6.32%	21	22.11%	67	70.53%
P20: Le manifiestan que están pendientes de usted.	7	7.37%	15	15.79%	26	27.37%	47	49.47%
P21: Le permiten expresar sus sentimientos cuando es atendido en TAR.	9	9.47%	10	10.53%	24	25.26%	52	54.74%
P22: Le responden de forma oportuna cuando hace preguntas.	1	1.05%	7	7.37%	32	33.68%	55	57.89%
P23: La enfermera identifica sus necesidades de tipo físico, psicológico y espiritual.	6	6.32%	22	23.16%	28	29.47%	39	41.05%
P24: La enfermera le escucha atentamente cuando establecen el diálogo.	3	3.16%	10	10.53%	28	29.47%	54	56.84%
P25: La enfermera muestra interés por su estado de ánimo.	6	6.32%	10	10.53%	34	35.79%	45	47.37%
P26: La enfermera le brinda un cuidado cálido y delicado cuando se atienden en el servicio.	1	1.05%	15	15.79%	28	29.47%	51	53.68%
P27: La enfermera le demuestra responsabilidad durante su atención.	1	1.05%	6	6.32%	29	30.53%	59	62.11%
P28: La enfermera respeta su decisión cuando Ud. toma una decisión relacionada a su tratamiento.	2	2.11%	5	5.26%	33	34.74%	55	57.89%
P29: La enfermera respeta su intimidad cuando es atendido(a).	3	3.16%	4	4.21%	20	21.05%	68	71.58%
P30: Ud. recibe los medicamentos indicados por el médico de forma oportuna.	1	1.05%	0	0.00%	13	13.68%	81	85.26%

3.2. Discusión

El VIH, a lo largo de los años se ha convertido en un reto para la salud pública a nivel mundial, a pesar de tener avances científicos, sigue siendo una lucha el tratar de detener la continuidad de esta infección. Para el año 2023, 30.7 millones de personas viviendo con el VIH (PVV) accedieron a la terapia antirretroviral. Actualmente; su control y prevención constituyen un reto para nuestro sistema de salud. (44) (45)

El paciente con VIH se caracteriza por enfrentar nuevos desafíos al momento de conocer su diagnóstico, pues, este se enfrenta al inicio de un tratamiento de por vida; dado que, la posibilidad de experimentar discriminación y estigmatización relacionados a su infección, resulta en un impact emocional significativo, un evento altamente estresante que, incluso, podría considerarse como traumático. Por lo que, a nivel emocional, este tipo de pacientes experimentan emociones negativas como tristeza, desesperanza, miedo, vergüenza, culpa, confusión, negación, entre otros; por lo que, es necesario en un 100% de un cuidado humanizado brindado por el equipo de salud, especialmente, por la enfermera, quién es la responsable de la atención directa al paciente. (46) (47)

Según Basurto L. (2024) refiere que el cuidado humanizado de enfermería es un proceso afectivo, reflexivo y efectivo en donde se reconoce a la persona como el objeto de cuidado, siendo un ser integral, con la capacidad de intervenir en la planeación y ejecución de sus cuidados, por medio, de un acercamiento significativo y respetuoso entre el cuidador y el ser de cuidado.; pues, este sujeto se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ya sea por enfermedad, condición o procedimiento quirúrgico y, se vuelve importante el brindar apoyo y cuidado en todos los aspectos. (48)

En la presente investigación, la población estudiada en su mayoría eran adultos jóvenes, de sexo masculino, de estado civil soltero, con grado de instrucción superior y con un período de tratamiento antirretroviral mayor de 7 meses; con respecto a la percepción del cuidado humanizado de la enfermera en pacientes en tratamiento antirretroviral de un centro de salud de Lima, Perú; se encontró que la mayoría presenta buena percepción, pero para un porcentaje significativo la percepción es regular; resultados similares al de Rojas O. (2019) (10) que en su

investigación titulada “Percepción del usuario acerca del cuidado humanizado de enfermería a personas con VIH/Sida atendidos en el Hospital General de Jaén, 2018” encontró que la percepción global del usuario acerca del cuidado humanizado obtenida en su mayoría es regular; además, también de resultados similares con el de Basurto L. (2024) (49) que en su investigación “Percepción del cuidado humanizado de enfermería en personas con VIH atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión, Huancayo 2024.”; concluyó que la percepción global acerca del cuidado humanizado es regular.

Esto indica que el cuidado humanizado que brinda la enfermera a los pacientes en tratamiento antirretroviral no es el ideal, debido a que no se está comprendiendo o considerando la existencia de los atributos básicos del ser humano como un sistema complejo. Que posiblemente se deba a múltiples factores como vocación, valores humanos, ética y moral del profesional.

Con respecto a la dimensión cualidades del hacer de enfermería, la mayoría de pacientes percibió que siempre tuvieron cuidado humanizado; sin embargo, un porcentaje significativo refirió que a veces: “se sienten tranquilos cuando la enfermera lo acompaña” y “le demuestran respeto por sus creencias y valores”, estos resultados son similares a Basurto L. (2024) en su investigación “Percepción del cuidado humanizado de enfermería en personas con VIH atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión, Huancayo 2024.”, donde en sus resultados, se evidenció que presenta una percepción regular en la dimensión Cualidades del hacer de enfermería cómo “se sienten tranquilos cuando la enfermera lo acompaña” y “le demuestran respeto por sus creencias y valores”.

Podemos inferir que el personal de enfermería no cuenta con características o atributos fundamentales para la atención al paciente en tratamiento antirretroviral, ya que, durante la atención descuida esa necesidad de compañía frente al dolor, angustia o miedo; así como también, se muestra cuestionante con la idiosincrasia de la persona acerca de su enfermedad.

Por otro lado, en relación a la dimensión apertura a la comunicación, los resultados evidenciaron que presenta buena percepción; sin embargo, existe un porcentaje significativo que presentó una percepción regular y refirió que solo a veces “la enfermera lo mira a los ojos cuando habla con él” o “la enfermera facilita el diálogo”; estos resultados son similares al trabajo de Rojas O. (2019) en su investigación titulada “Percepción del usuario acerca del cuidado humanizado de

enfermería a personas con VIH/SIDA atendidos en el Hospital General de Jaén, 2018” donde obtuvo que la percepción de la dimensión apertura a la comunicación fue regular; así como también de manera similar se encontró en la tesis de Olivera M. (2018) en su investigación “Cuidado humanizado de enfermería desde la percepción del paciente hospitalizado, servicio de medicina del Hospital General de Jaén, 2017” (50); que el profesional de enfermería algunas veces le hacen sentir bien cuando dialogan y algunas veces le hacen sentir tranquilo cuando está con el profesional de enfermería.

Lo cuál resulta que la enfermera está aplicando inadecuadamente los principios de la comunicación tales como sencillez, cercanía, claridad, brevedad y cortesía, siendo principios relacionados a la comunicación efectiva que un profesional de enfermería debe aprender a manejar durante su preparación académica. (51)

Por último, con relación a la dimensión disposición para la atención, se pudo evidenciar en los resultados que presenta una buena percepción; sin embargo, un grupo significativo presentó que a veces “la enfermera le responde oportunamente” y que a veces “le atiende oportunamente”; resultados similares se encontró en Olivera M. (2018) en su investigación “Cuidado humanizado de enfermería desde la percepción del paciente hospitalizado, servicio de medicina del Hospital General de Jaén, 2017”, donde el profesional de enfermería algunas veces responde y atiende de manera oportuna al paciente con VIH; del mismo modo, se encontró de manera similar en la tesis de Basurto L (2024) en su investigación “Percepción del cuidado humanizado de enfermería en personas con VIH atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión, Huancayo, 2024”.

Pudiendo inferir que la enfermera del servicio está atendiendo sin considerar la prioridad, la necesidad del paciente en tratamiento antirretroviral que podría estar relacionado a la demanda y exigencias del paciente.

4. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones

Primero; se determinó que la percepción del cuidado humanizado de la enfermera en pacientes en tratamiento antirretroviral en un establecimiento de salud de Lima, Perú, 2024; es buena.

Segundo, con respecto a la percepción del cuidado humanizado de la enfermera en pacientes en tratamiento antirretroviral en la dimensión cualidades del hacer de enfermería, se encontró un porcentaje significativo regular en los aspectos como “demuestra respeto por sus creencias y valores” y “se siente tranquilo cuando la enfermera está con usted”.

Tercero, con relación a la percepción del cuidado humanizado de la enfermera en pacientes en tratamiento antirretroviral en la dimensión apertura para la comunicación se señala un porcentaje significativo como regular en aspectos relacionados “la enfermera lo mira a los ojos cuando conversa con usted” y “la enfermera facilita el diálogo con usted”.

Finalmente, cuarto; la percepción del cuidado humanizado de la enfermera en paciente en tratamiento antirretroviral en la dimensión disposición para la atención, se evidencia que es regular en aspectos como “le responden de forma oportuna cuando hace preguntas” y “le dan atención de manera oportuna”.

4.2. Recomendaciones

Al Colegio de Enfermeros del Perú, reflexionar sobre los lineamientos y perfil profesional que debe tener cada licenciado para brindar un cuidado humanizado bueno.

Al profesional de Enfermería que labora en el Servicio de TAR del Centro de Salud, reflexionar los aspectos relacionados a la práctica profesional que realiza diariamente y mantener su perfil de bueno en el cuidado humanizado en la atención a los pacientes en tratamiento antirretroviral.

A las universidades, evaluar la vocación que presenta cada estudiante para brindar una atención centrada en el cuidado humanizado dedicado al paciente.

A la formación académica, priorizar en aspectos relacionados a la comunicación, relación enfermero - paciente, relaciones interpersonales, y priorizar y fortalecer en el desarrollo de asignaturas que profundicen en la práctica de estos aspectos para con el paciente de cuidado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. VIH y sida [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>
2. VIH [Internet]. National Library of Medicine; [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/hiv.html>
3. UNAIDS_FactSheet_es.pdf [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_es.pdf
4. VIH/SIDA - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. 2024 [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/vihsida>
5. vih-sida_202311_01_140824.pdf [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/vih-sida/vih-sida_202311_01_140824.pdf
6. Dirección de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis (DPVIH) [Internet]. 2024 [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.gob.pe/23137-ministerio-de-salud-direccion-de-prevencion-y-control-de-vih-sida-enfermedades-de-transmision-sexual-y-hepatitis-dpvih>
7. Baca Chancafe JM. Percepción del cuidado enfermero en personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida en Chiclayo, 2021. 2022 [citado 4 de diciembre de 2024]; Disponible en: <http://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/5451>
8. García Palomino GA, Mora Muñoz JE, Chimbo Aldaz JO, Elizalde Martínez KS. Percepción de enfermería sobre los cuidados humanizados en pacientes portadores de enfermedades infecto contagiosas. Cienc Lat Rev Científica Multidiscip. 30 de agosto de 2022;6(4):2574-600.
9. Tejada Chavarría VE. Percepción del paciente con VIH sobre el cuidado humanizado que brinda el personal de enfermería en el servicio de centro quirúrgico en un hospital nacional de Lima, 2019. 2 de septiembre de 2019 [citado 4 de diciembre de 2024]; Disponible en: <http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/3040>
10. Rojas Pérez O. Percepción del usuario acerca del cuidado humanizado de enfermería a personas con VIH/sida atendidas en el Hospital General de Jaén 2018. Univ Nac Cajamarca [Internet]. 2019 [citado 4 de diciembre de 2024]; Disponible en: <http://repositorio.unc.edu.pe/handle/20.500.14074/2913>
11. Chuquin Chavez EM, Correa Moreano LP. Calidad de vida y adherencia al TARGA en

- personas con VIH en el hospital de Ventanilla, Lima-Perú 2023. Repos Inst - UCV [Internet]. 2023 [citado 4 de diciembre de 2024]; Disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/126318>
12. Herrera VBH, Agila BMT, Vallejo MAI. Percepción de cuidado humanizado de enfermería en pacientes con insuficiencia renal crónica. En 2020 [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.semanticscholar.org/paper/Percepci%C3%B3n-de-cuidado-humanizado-de-enfermer%C3%ADa-en-Herrera-Agila/79b3b4f09d8a2c692713bd321c82b126098de445>
 13. Swinkels HM, Justiz Vaillant AA, Nguyen AD, Gulick PG, Pinto KM. HIV and AIDS (Nursing). En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK568679/>
 14. VIH y el SIDA: Conceptos básicos | NIH [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://hivinfo.nih.gov/es/understanding-hiv/fact-sheets/vih-y-el-sida-conceptos-basicos>
 15. VIH/sida - Síntomas y causas - Mayo Clinic [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/hiv-aids/symptoms-causes/syc-20373524>
 16. 6345.pdf [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/6345.pdf>
 17. Manual MSD versión para profesionales [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Infección por el virus de inmunodeficiencia humana (HIV) - Enfermedades infecciosas. Disponible en: <https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/virus-de-inmunodeficiencia-humana-hiv/infección-por-el-virus-de-inmunodeficiencia-humana-hiv>
 18. ¿Qué es VIH / SIDA? [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.cancer.org/es/cancer/prevencion-del-riesgo/infecciones/infeccion-con-vih-sida/qu-e-es-vih-y-sida.html>
 19. Manual MSD versión para profesionales [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Tratamiento antirretroviral de la infección por HIV - Enfermedades infecciosas. Disponible en: <https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/virus-de-inmunodeficiencia-humana-hiv/tratamiento-antirretroviral-de-la-infeccion-por-hiv>

ciencia-humana-hiv/tratamiento-antirretroviral-de-la-infección-por-hiv

20. Manual MSD versión para profesionales [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Sistema del antígeno leucocitario humano (HLA) - Inmunología y trastornos alérgicos. Disponible en: <https://www.msdmanuals.com/es/professional/inmunología-y-trastornos-alérgicos/biología-del-sistema-inmunitario/sistema-del-antígeno-leucocitario-humano-hla>
21. Pruebas de histocompatibilidad (HLA) [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.labtestsonline.es/tests/hla>
22. Resolución Ministerial N°1024-2020-MINSA.pdf [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1482085/Resoluci%C3%B3n%20Ministerial%20N%C2%B01024-2020-MINSA.PDF>
23. <https://www.cun.es> [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Qué es Paciente. Diccionario Médico. Clínica U. Navarra. Disponible en: <https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/paciente>
24. Elío-Calvo D. EL PACIENTE COMO PERSONA. Rev Médica Paz. 2022;28(1):83-90.
25. Boff L. O Cuidar e o ser cuidado na prática dos operadores de saúde. Ciênc Saúde Coletiva. 3 de febrero de 2020;25:392-392.
26. (PDF) Rol de los profesionales de enfermería en el sistema de salud colombiano. ResearchGate [Internet]. 22 de octubre de 2024 [citado 4 de diciembre de 2024]; Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/324851237_Rol_de_los_profesionales_de_enfermeria_en_el_sistema_de_salud_colombiano
27. Mares BH, Camacho RA. ¿Qué es y qué no es el cuidado de enfermería? Enferm Actual En Costa Rica [Internet]. 2021 [citado 4 de diciembre de 2024];(40). Disponible en: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/enfermeria/article/view/40788>
28. Guizado Tello CL. Cuidado humanizado que brinda el profesional de enfermería según la teoría de Jean Watson en el servicio de emergencia del Hospital Nacional Hipólito Unanue Lima, 2019. Univ Nac Federico Villarreal [Internet]. 2020 [citado 4 de diciembre de 2024]; Disponible en: <https://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/4249>
29. Cruz Riveros C. La naturaleza del cuidado humanizado. Enferm Cuid Humaniz.

2020;9(1):21-32.

30. Prado Ramos R. Conocimiento sobre el cuidado humanizado de Jean Watson del profesional de enfermería y su relación en la atención del paciente hospitalizado por casos quirúrgicos y traumatológicos en el servicio de cirugía del Hospital II Pasco – Essalud 2022. Repos Inst-Wien [Internet]. 23 de octubre de 2022 [citado 4 de diciembre de 2024]; Disponible en: <https://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/20.500.13053/8073>
31. PERCEPCIÓN by FRANKLIN CHILQUINGA - Issuu [Internet]. 2018 [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: https://issuu.com/franklinchilquinga/docs/la_percepci_n
32. Elizabeth RM, Inelda CM, Yanileth PP, Anny M, Verónica JZ. CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS. CARTAGENA, COLOMBIA. 2013;
33. Rivera-Álvarez LN, Triana Á, Rivera-Álvarez LN, Triana Á. Proceso de construcción y validación del instrumento Percepción de Comportamientos de Cuidado Humanizado de Enfermería (PCHE-III). Index Enferm [Internet]. marzo de 2023 [citado 4 de diciembre de 2024];32(1). Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1132-12962023000100014&lng=es&nrm=iso&tlng=es
34. Fernández-Silva CA, Mansilla-Cordeiro EJ, Aravena Flores A, Antiñirre Mansilla B, Garcés Saavedra MI, Fernández-Silva CA, et al. Percepción de los pacientes hospitalizados respecto del cuidado de enfermería. Enferm Cuid Humaniz [Internet]. junio de 2022 [citado 4 de diciembre de 2024];11(1). Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2393-66062022000101201&lng=es&nrm=iso&tlng=es
35. González-Hernández OJ. Validez y confiabilidad del instrumento “Percepción de comportamientos de cuidado humanizado de enfermería PCHE 3ª versión”. Aquichan [Internet]. 12 de agosto de 2015 [citado 4 de diciembre de 2024];15(3). Disponible en: <https://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/4806>
36. ICN - International Council of Nurses [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Definiciones de enfermería. Disponible en: <https://www.icn.ch/es/recursos/definiciones-de-enfermeria>
37. El profesional de enfermería en la promoción de salud en el segundo nivel de atención.

Rev EUGENIO ESPEJO. 11 de enero de 2022;16(1):98-111.

38. Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros 2024 - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/campanas/dia-internacional-enfermeras-enfermeros-2024>
39. (PDF) Rol de los profesionales de enfermería en el sistema de salud colombiano. ResearchGate [Internet]. 22 de octubre de 2024 [citado 4 de diciembre de 2024]; Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/324851237_Rol_de_los_profesionales_de_enfermeria_en_el_sistema_de_salud_colombiano
40. Lifeder [Internet]. 2022 [citado 4 de diciembre de 2024]. Método descriptivo: qué es, características, etapas, ejemplos. Disponible en: <https://www.lifeder.com/metodo-descriptivo/>
41. Arévalo JA. Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis [Internet]. Universo Abierto. 2021 [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://universoabierto.org/2021/03/30/metodologia-de-la-investigacion-cuantitativa-cualitativa-y-redaccion-de-la-tesis/>
42. Scopus preview - Scopus - Document details - Experimental studies: Research designs for the evaluation of interventions in clinical settings [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85054126663&doi=10.29262%2fram.v65i2.376&origin=inward&txGid=399e2426d6c196669ec00494e1affa60>
43. Estadística P y. Probabilidad y Estadística. 2021 [citado 4 de diciembre de 2024]. ¿Qué es el muestreo por conveniencia? ¿Y cuándo se utiliza? Disponible en: <https://www.probabilidadyestadistica.net/muestreo-por-conveniencia/>
44. boletin_202428_04_083750_3.pdf [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/boletin/boletin_202428_04_083750_3.pdf
45. vih-sida_20246_16_153419.pdf [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/vih-sida/vih-sida_20246_16_153419.pdf
46. Radusky PD, Mikulic IM. Impacto Emocional Del Diagnóstico De Vih En Personas Residentes En Buenos Aires. Anu Investig. 2018;XXV:107-16.
47. El VIH y la salud mental | NIH [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible

en: <https://hivinfo.nih.gov/es/understanding-hiv/fact-sheets/el-vih-y-la-salud-mental>

48. La importancia del cuidado humanizado en la enfermería: consejos y claves prácticas - serEnfermera [Internet]. 2023 [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://serenfermera.com/cuidado-humanizado-en-enfermeria/>
49. Basurto Romero LI. Percepción del cuidado humanizado de enfermería en personas con VIH atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión, Huancayo 2024. Univ Priv Huancayo Frankl Roosevelt [Internet]. 18 de mayo de 2024 [citado 4 de diciembre de 2024]; Disponible en: <http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/handle/20.500.14140/2190>
50. T016_47050359_T.pdf [Internet]. [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: https://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14074/2142/T016_47050359_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
51. Admin. ¿Cuáles son los principios de la comunicación? [Internet]. La comunicación. 2017 [citado 4 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://la-comunicacion.com/cuales-son-los-principios-de-la-comunicacion>

Anexos

Anexo 1: Operacionalización de variables.

Anexo 2: Cálculo del tamaño de muestra.

Anexo 3: Instrumento.

Anexo 4: Cálculo de CVC

Anexo 5: Libro de Códigos.

Anexo 6: Matriz de datos

Anexo 7: Consentimiento informado

Anexo 8: Solicitud a la Escuela Profesional de Enfermería

Anexo 9: Solicitud al Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Medicina “San Fernando”

Anexo 10: Autorización de Ejecución de Proyecto de Investigación

ANEXOS

ANEXO 1: Operacionalización de variables

Variable	Tipo de variable	Dimensiones	Definición de dimensión	Indicadores	Valor final de la variable
Percepción del cuidado humanizado en paciente antirretroviral	Cuantitativa	Cualidades del hacer de enfermería	Refiere a las cualidades y valores que caracterizan al profesional de enfermería que brinda cuidado.	1. Le hacen sentir como una persona	(1) Bueno (2) Regular (3) Malo
				2. Le tratan con amabilidad	
				6. Le hacen sentirse bien atendido cuando dialogan con usted.	
				7. Le hacen sentir tranquilidad cuando están con usted.	
				8. Le generan confianza cuando lo cuidan.	
				15. Le explican los cuidados usando un tono de voz pausado.	
				17. Le demuestran respeto por sus creencias y valores.	
		Apertura para la comunicación	Refiere a la apertura por parte del profesional de enfermería quien brinda el cuidado a un proceso dinámico, fundamental	4. Le miran a los ojos cuando le hablan.	
				5. Le dedican tiempo para aclararle sus inquietudes.	
				9. Le facilitan el diálogo.	

			para el crecimiento, el cambio y la conducta, mediante las habilidades comunicativas que hacen posible la transmisión de una realidad.	10. Le explican previamente los procedimientos.	
				11. Le responden con seguridad y claridad a sus preguntas.	
				12. Le indican su nombre antes de realizar un procedimiento.	
				14. Le dan indicaciones sobre su atención cuando usted lo requiere o según su situación de salud.	
				19. Le proporcionan información suficiente y oportuna para que pueda tomar decisiones sobre su situación de salud.	
		Disposición para la atención	Refiere a la disposición que surge de ser solicitado por el sujeto de cuidado, que requiere de una sumersión en su realidad para descubrir sus necesidades y fortalecer el vínculo.	3. Le muestra interés por brindarle comodidad durante la atención.	
				13. Le dedica el tiempo requerido para su atención.	
				16. Le llaman por su nombre.	
				18. Le atienden oportunamente.	
				20. Le manifiestan que están pendientes de usted.	
				21. Le permiten expresar sus sentimientos sobre la enfermedad y el tratamiento.	
				22. Responden oportunamente.	

				23. Identifican sus necesidades de tipo físico, psicológico y espiritual.	
				24. Le escuchan atentamente.	
				25. Le preguntan y se preocupan por su estado de ánimo.	
				26. Le brindan un cuidado cálido y delicado.	
				27. Le demuestran que son responsables de su atención.	
				28. Respetan su decisión.	
				29. Respetan su intimidad.	
				30. Entregan a tiempo los medicamentos prescritos por el médico.	

Definición operacional de la variable

Es la percepción individual que realizan los pacientes del programa TAR que consiste en recibir, interpretar y comprender los cuidados que le brinda la enfermera del Centro de Salud Max Arias Schreibber y que será medido con un cuestionario tipo Lickert y tendrá los valores finales de bueno, regular y malo.

ANEXO 2: Cálculo de tamaño de muestra

$$n = \frac{Z^2 \times p \times (1 - p)}{E^2}$$

N: 100

e: 0.5

p: 50%

Z: 1.96

ANEXO 3: Instrumento

Instrumento tomado de Percepción de Comportamientos de Cuidado Humanizado de Enfermería (PCHE-III) (34) (35) y fue adaptado a la realidad local por el investigador.

Cuestionario: “Percepción de Comportamientos de Cuidado Humanizado de Enfermería”

Presentación

Estimado(a) participante, soy Encarnación Pasaca Eyder Fernando, estudiante de enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estoy realizando un estudio que tiene como objetivo determinar la percepción del cuidado humanizado de la enfermera en pacientes en tratamiento antirretroviral de un centro de salud de Lima, 2024., para lo cual solicito su colaboración respondiendo con la mayor honestidad el siguiente cuestionario, el cuál ayudará a mejorar la atención brindada por el profesional de enfermería. La información que Ud. brinde es completamente anónima y se usará solo con fines académicos. Agradezco por anticipado su colaboración.

1. Datos generales:

Instrucciones: A continuación, se le formulará una serie de preguntas, para lo que tendrá que responder con un aspa o con un (x) en las casillas y complete los espacios en blanco según indique. Solo marcar una alternativa.

1. Edad:

- a. De 18 a 39 años
- b. De 40 a 59 años
- c. De 60 a 79 años

2. Sexo

- a. Masculino b. Femenino c. Otro(especifique):

3. Estado civil

- a. Soltero
- b. Conviviente
- c. Casado
- d. Divorciado
- e. Viudo

4. Grado de instrucción

- a. Primaria
- b. Secundaria
- c. Técnico
- d. Profesional
- e. Sin estudios

5. ¿Usted tiene como diagnóstico médico: VIH?

- a. Sí b. No

6. ¿Usted recibe tratamiento antirretroviral?

- a. Sí b. No

7. ¿Usted por cuánto tiempo se encuentra ya en tratamiento antirretroviral?

- a. De 1 a 3 meses

- b. De 4 a 6 meses.
- c. De 7 meses a 1 año.
- d. Más de 1 año.

2. Cuestionario - Cuidado Humanizado de Enfermería

Instrucciones: A continuación, se le formulará una serie de enunciados referidos al cuidado que brinda la enfermera, para lo que tendrá que responder con un aspa o con un (x) en las casillas y complete los espacios en blanco según indique. Solo marcar una alternativa.

(1)	(2)	(3)	(4)
Nunca	Algunas veces	Casi siempre	Siempre

ITEM		Nunca (1)	Algunas veces (2)	Casi siempre (3)	Siempre (4)
1	La enfermera lo trata con respeto en la atención.				
2	La enfermera le trata con amabilidad cuando le atiende.				
3	La enfermera muestra interés para brindarle comodidad al entregarle su medicamento.				
4	La enfermera lo mira a los ojos cuando conversa con usted.				
5	La enfermera dedica tiempo para aclararle las dudas o inquietudes que tenga.				
6	Se siente bien atendido cuando dialogan con usted.				
7	Se siente tranquilo cuando la enfermera está con usted.				
8	El ambiente es de confianza cuando recibe la atención.				
9	La enfermera facilita el diálogo con usted.				
10	Le explican previamente los procedimientos a realizar.				
11	Le responden con seguridad y claridad a sus preguntas.				
12	Lo llaman por su nombre antes de realizar un procedimiento.				
13	La enfermera dedica el tiempo requerido para su atención.				
14	La enfermera brinda indicaciones sobre su atención cuando usted lo requiere o según su situación de salud.				
15	Le explican los cuidados usando un tono de voz pausado.				
16	La enfermera lo llama por su nombre.				
17	Le demuestran respeto por sus creencias y valores.				
18	Le dan atención de manera oportuna.				
19	Le proporcionan información suficiente y oportuna para que pueda tomar decisiones sobre su situación de salud.				

20	Le explican que están pendientes de usted.				
21	Le permiten expresar sus sentimientos cuando es atendido en el servicio de TARGA.				
22	Le responden de forma oportuna cuando hace preguntas.				
23	La enfermera identifica sus necesidades de tipo físico, psicológico y espiritual.				
24	La enfermera le escucha atentamente cuando establecen el diálogo.				
25	La enfermera muestra interés por su estado de ánimo.				
26	La enfermera le brinda un cuidado cálido y delicado cuando se atiende en el servicio.				
27	La enfermera le demuestra responsabilidad durante su atención.				
28	La enfermera respeta su decisión cuando Ud. toma una decisión relacionada a su tratamiento.				
29	La enfermera respeta su intimidad cuando es atendido(a)				
30	Usted recibe los medicamentos indicados por el médico de forma oportuna.				

¡Muchas gracias por su participación!

ANEXO 4: Cálculo de CVC

Claridad

Item	J1	j2	j3	j4	j5	Σ xij	(Mx)	CVCi	Pei	CVCic	
1	3	5	4	3	5	20	4.0000	0.8000	0.0003	0.7997	Acceptable
2	5	5	5	4	4	23	4.6000	0.9200	0.0003	0.9197	Excelente
3	3	5	4	4	4	20	4.0000	0.8000	0.0003	0.7997	Acceptable
4	5	5	5	5	5	25	5.0000	1.0000	0.0003	0.9997	Excelente
5	5	5	5	5	4	24	4.8000	0.9600	0.0003	0.9597	Excelente
6	4	5	5	5	5	24	4.8000	0.9600	0.0003	0.9597	Buena
7	0	5	5	4	5	19	3.8000	0.7600	0.0003	0.7597	Excelente
8	4	5	5	5	4	23	4.6000	0.9200	0.0003	0.9197	Buena
9	5	5	5	5	4	24	4.8000	0.9600	0.0003	0.9597	Excelente
10	4	5	5	4	4	22	4.4000	0.8800	0.0003	0.8797	Buena
11	4	5	5	4	4	22	4.4000	0.8800	0.0003	0.8797	Buena
12	5	5	5	5	5	25	5.0000	1.0000	0.0003	0.9997	Excelente
13	5	5	5	5	4	24	4.8000	0.9600	0.0003	0.9597	Excelente
14	5	5	4	5	4	23	4.6000	0.9200	0.0003	0.9197	Buena
15	4	5	5	5	4	23	4.6000	0.9200	0.0003	0.9197	Buena
16	4	5	5	2	5	21	4.2000	0.8400	0.0003	0.8397	Buena
17	5	0	5	5	4	19	3.8000	0.7600	0.0003	0.7597	Excelente
18	4	5	5	3	4	21	4.2000	0.8400	0.0003	0.8397	Buena
19	5	5	4	5	4	23	4.6000	0.9200	0.0003	0.9197	Buena
20	4	5	5	5	4	23	4.6000	0.9200	0.0003	0.9197	Buena
21	5	5	5	3	4	22	4.4000	0.8800	0.0003	0.8797	Excelente
22	4	5	5	5	4	23	4.6000	0.9200	0.0003	0.9197	Buena
23	5	5	4	5	4	23	4.6000	0.9200	0.0003	0.9197	Buena
24	5	5	4	5	4	23	4.6000	0.9200	0.0003	0.9197	Buena
25	5	5	4	5	4	23	4.6000	0.9200	0.0003	0.9197	Buena
26	5	5	4	5	4	23	4.6000	0.9200	0.0003	0.9197	Buena
27	5	5	4	5	4	23	4.6000	0.9200	0.0003	0.9197	Buena
28	5	5	3	5	4	22	4.4000	0.8800	0.0003	0.8797	Buena
29	5	5	5	5	4	24	4.8000	0.9600	0.0003	0.9597	Excelente
30	4	5	5	5	5	24	4.8000	0.9600	0.0003	0.9597	Buena
								Σ		27.1104	
						n de ítems	30	CVCt		0.9037	
								CVCtc		0.9034	

Relevancia

Item	J1	j2	j3	j4	j5	Σ xij	(Mx)	CVCi	Pei	CVCic	
1	3	5	5	4	5	22	4.4000	0.8800	0.0003	0.8797	Buena
2	5	5	5	5	5	25	5.0000	1.0000	0.0003	0.9997	Excelente
3	2	5	5	4	5	21	4.2000	0.8400	0.0003	0.8397	Acceptable
4	5	5	5	5	5	25	5.0000	1.0000	0.0003	0.9997	Excelente
5	4	5	5	5	5	24	4.8000	0.9600	0.0003	0.9597	Buena
6	4	5	5	5	5	24	4.8000	0.9600	0.0003	0.9597	Buena
7	0	5	5	5	5	20	4.0000	0.8000	0.0003	0.7997	Excelente
8	4	5	5	5	5	24	4.8000	0.9600	0.0003	0.9597	Buena
9	4	5	5	5	5	24	4.8000	0.9600	0.0003	0.9597	Buena
10	3	5	5	5	5	23	4.6000	0.9200	0.0003	0.9197	Buena
11	3	5	5	5	5	23	4.6000	0.9200	0.0003	0.9197	Buena
12	4	5	5	5	5	24	4.8000	0.9600	0.0003	0.9597	Buena
13	5	5	5	5	5	25	5.0000	1.0000	0.0003	0.9997	Excelente
14	5	5	5	5	5	25	5.0000	1.0000	0.0003	0.9997	Excelente
15	5	5	5	5	5	25	5.0000	1.0000	0.0003	0.9997	Excelente
16	4	5	5	2	5	21	4.2000	0.8400	0.0003	0.8397	Buena
17	5	5	5	5	5	25	5.0000	1.0000	0.0003	0.9997	Excelente
18	4	0	5	5	5	19	3.8000	0.7600	0.0003	0.7597	Buena
19	4	5	5	5	5	24	4.8000	0.9600	0.0003	0.9597	Buena
20	5	5	5	5	5	25	5.0000	1.0000	0.0003	0.9997	Excelente
21	5	5	5	4	5	24	4.8000	0.9600	0.0003	0.9597	Excelente
22	4	5	5	5	5	24	4.8000	0.9600	0.0003	0.9597	Buena
23	5	5	5	5	5	25	5.0000	1.0000	0.0003	0.9997	Excelente
24	5	5	5	5	5	25	5.0000	1.0000	0.0003	0.9997	Excelente
25	4	5	5	5	5	24	4.8000	0.9600	0.0003	0.9597	Buena
26	5	5	5	5	5	25	5.0000	1.0000	0.0003	0.9997	Excelente
27	5	5	5	5	5	25	5.0000	1.0000	0.0003	0.9997	Excelente
28	5	5	5	5	5	25	5.0000	1.0000	0.0003	0.9997	Excelente
29	5	5	5	5	5	25	5.0000	1.0000	0.0003	0.9997	Excelente
30	4	5	5	5	5	24	4.8000	0.9600	0.0003	0.9597	Buena
								Σ		28.5504	
						n de ítems	30	CVCt		0.9517	
								CVCtc		0.9514	

ANEXO 5: Libro de códigos

N° PREGUNTA	ITEMS	CATEGORÍA	CÓDIGO
DATOS GENERALES			
P1	RANGO DE EDAD	De 18 a 30 años	1
		De 40 a 59 años	2
		De 60 a 79 años	3
P2	SEXO	Masculino	1
		Femenino	2
P3	ESTADO CIVIL	Soltero	1
		Conviviente	2
		Casado	3
		Divorciado	4
		Viudo	5
P4	GRADO DE INSTRUCCIÓN	Primaria	1
		Secundaria	2
		Técnico	3
		Profesional	4
		Sin estudios	5
P5	¿Ud. tiene como diagnóstico médico: VIH?	Si	1
		No	2
P6	¿Ud. recibe tratamiento antirretroviral?	Si	1
		No	2
P7	¿Ud. por cuánto tiempo ha estado en tratamiento antirretroviral?	De 1 a 3 meses	1
		De 4 a 6 meses	2
		De 7 meses a 1 año	3
		Más de 1 año	4

Dimensión: Cualidades del hacer de Enfermería			
P1	La enfermera lo hace sentir como persona	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P2	La enfermera le trata con amabilidad cuando lo atiende	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P6	Le hacen sentirse bien atendido cuando dialogan con usted.	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P7	Le hacen sentir tranquilidad cuando están con usted.	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P8	Ud. siente un ambiente de confianza cuando lo atienden	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P15	Le explican los cuidados usando un tono de voz pausado	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4

P17	Le demuestran respeto por sus creencias y valores	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
Dimensión: Apertura para la comunicación			
P4	La enfermera lo mira a los ojos cuando se comunica con Ud.	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P5	La enfermera dedica tiempo para aclararle sus inquietudes	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P9	La enfermera facilita el diálogo con Ud.	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P10	Le explican previamente los procedimientos.	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P11	Le responden con seguridad y claridad sus preguntas	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4

P12	Lo llaman por su nombre antes de realizar un procedimiento	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P14	La enfermera brinda indicaciones sobre su atención cuando usted lo requiere o según su situación de salud	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P19	Le proporcionan información suficiente y oportuna para que pueda tomar decisiones sobre su situación de salud	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
Dimensión: Disposición para la atención			
P3	La enfermera muestra interés para brindarle comodidad al entregarle su medicamento	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P13	La enfermera dedica el tiempo requerido para su atención	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P16	La enfermera lo llama por su nombre	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4

P18	Le atienden oportunamente	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P20	Le manifiestan que están pendientes de usted.	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P21	Le permiten expresar sus sentimientos cuando es atendido en TAR	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P22	Le responden de forma oportuna cuando hace preguntas	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P23	La enfermera identifica sus necesidades de tipo físico, psicológico y espiritual	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P24	La enfermera le escucha atentamente cuando establecen el diálogo	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P25	La enfermera muestra interés por su estado de ánimo	Nunca	1

		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P26	La enfermera le brinda un cuidado cálido y delicado cuando se atiende en el servicio	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P27	La enfermera le demuestra responsabilidad durante su atención	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P28	La enfermera respeta su decisión cuando Ud. toma una decisión relacionada a su tratamiento.	Nunca	
		Algunas veces	1
		Casi siempre	2
		Siempre	3
P29	La enfermera respeta su intimidad cuando es atendido(a)	Nunca	4
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4
P30	Ud. recibe los medicamentos indicados por el médico de forma oportuna	Nunca	1
		Algunas veces	2
		Casi siempre	3
		Siempre	4

ANEXO 6: Matriz de datos

[illegible]

ANEXO 7: Consentimiento información

Buenos días estimado participante, usted ha sido invitado a participar de forma voluntaria y anónima en el estudio **“Percepción del cuidado humanizado de la enfermera en pacientes en tratamiento antirretroviral de un centro de salud, Lima - Perú, 2024”** que tiene como objetivo determinar la percepción sobre el cuidado humanizado de la enfermera en pacientes en tratamiento antirretroviral de un establecimiento de salud del primer nivel 2024, realizado por Eyder Encarnación, estudiante de 4to año de la carrera de Enfermería.

Si usted decide participar, se le aplicará el instrumento “Percepción de Comportamientos del Cuidado Humanizado de Enfermería”, y la información brindada será confidencial y anónima, y las únicas personas autorizadas para ver sus respuestas son las personas que trabajan en el proyecto.

Si está de acuerdo con lo leído anteriormente, por favor coloque su firma en el espacio seleccionado.

Firma:

Anexo 8: Autorización a la Escuela Profesional de Enfermería

	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA FACULTAD DE MEDICINA ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA "Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"	
Lima 04 de junio del 2024		
CARTA N°45-FM-EPE-FM-2024 Dra. Delia Florencia Dávila Vigil Directora DIRIS LIMA CENTRO <u>Presente.</u> -		
De mi consideración:		
Es grato dirigirme a Usted, para saludarle y a la vez, manifestarle que el alumno de la Escuela Profesional de Enfermería Sr. Eyder Fernando Encarnación Pasaca, con número de matrícula N° 21010351, identificado con DNI 75533595, con domicilio en Jirón Mariano Varela 551 ubicado en el distrito de San Martín de Porres, la cual viene desarrollando su proyecto de investigación:		
"PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE LA ENFERMERA EN PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL 2024"		
En tal sentido, se solicita muy amablemente brinde usted o autorice a quien corresponda las facilidades necesarias para que la mencionada egresada pueda recolectar información y aplicar su instrumento durante los meses de agosto a septiembre del 2024.		
Sin otro en particular y agradeciéndole anticipadamente por todas las facilidades que brinde, me despido de usted.		
Muy Atentamente.		
 DRA. ANGELA ROCIO CORNEJO VALDIVIA Directora Escuela Profesional de Enfermería UNMSM		
ARCV/jfo Av. Grau 755 – Lima 1 – Apartado Postal 529 – Lima 100 – Perú, E.A.P. de Enfermería 619 7000 anexo 4619 Web: www.unmsm.edu.pe/medicina - E-mail de la Escuela de Enfermería: epenfermeria.medicina@unmsm.edu.pe		

Anexo 9: Solicitud al Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Medicina “San Fernando”



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE MEDICINA
INSTITUTO DE ÉTICA EN SALUD
COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN

*“Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y la
Commemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”*



ACTA DE EVALUACIÓN ÉTICA DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO DE ESTUDIO N°: 0221-2024

En Lima, a los diecinueve días del mes de abril, en Sesión del COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, previa evaluación del Proyecto de Investigación de Pregrado titulado: **“Percepción del cuidado humanizado en pacientes en TAR de un establecimiento de salud del primer nivel, Lima – Perú, 2024”** presentado por **Eyder Fernando Encarnación Pasaca** con código 21010351, de la escuela profesional de enfermería, proyecto de investigación como parte del Curso de Indagación Científica en Enfermería I para ser ejecuta en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

ACUERDA:

Dar por **APROBADO** dicho Proyecto, considerando que se ha cumplido satisfactoriamente con las recomendaciones en aspectos Científicos Técnicos y Éticos para la investigación en seres humanos.

“El presente documento tiene vigencia a partir de la fecha y expira el 18 de agosto de 2025”

Lima, 19 de agosto de 2024




JUAN CARLOS OCAMPO ZEGARRA
PRESIDENTE DEL CEI / FM / UNMSM
FACULTAD DE MEDICINA SAN FERNANDO
CÓDIGO DOCENTE: 043079
CMP: 043040 - RNE: 028960 - RNSE: S00415

Dr. Juan Carlos Ocampo Zegarra
Presidente del CEI/FM/UNMSM

Anexo 10: Autorización de Ejecución de Proyecto de Investigación.

 PERÚ Ministerio de Salud	DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD Lima Centro	
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año de Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"		
CONSTANCIA N° 62		
AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		
ACTA N°10 -2024-COM.INV-DIRIS-LC		
EXPEDIENTE N.º 202456401		
MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD L.C. Centro de Salud "MARIA ANTONIA SCHREIBER" RECEPCION Registro: _____ Fecha: 15-10-24 Firma: _____ Hora: 10:36		

La que suscribe, Directora General de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, da Constancia que:

EYDER FERNANDO ENCARNACION PASACA

Autor del Proyecto de Investigación: **"PERCEPCION DEL CUIDADO HUMANIZADO DE LA ENFERMERA EN PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL 2024"** ha cumplido con los requisitos exigidos por la Unidad Funcional de Docencia e Investigación y el Comité de Investigación de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, dando por **APROBADO**, la Autorización para la Ejecución del Proyecto de Investigación, teniendo una vigencia de:

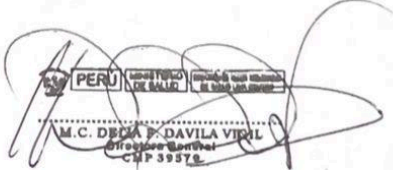
FECHA DE INICIO : 25 de Setiembre del 2024.
FECHA DE TÉRMINO : 31 de Marzo del 2025.

Asimismo, se le informa que su responsabilidad culmina con la presentación del informe Final, la publicación y socialización de resultados con las Oficinas, Estrategias y Establecimientos de Salud de interés de la jurisdicción, en bien de la Salud Pública del País.

Esperando el cumplimiento de todo lo antes mencionado, quedo de usted.

Lima, 26 de Setiembre del 2024.

Atentamente,


M.C. DEIDA P. DAVILA VIRIL
Directora General
C.M.P. 39578


MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD L.C.
LIMA CENTRO
DFDV/RUMC/LIMA CENTRO